

Información Paciente

Nombre : Ronald Sepulveda Castro
Edad : 33a 5m 6d
Dirección : Parinacota 10675 D 26

Rut : 17.378.637-9
Fecha Nacto: 07/09/1989
Comuna : Puente Alto

N° Archivo : 0523987
Sexo : Masculino
Teléfono : 962566824

N° Epicrisis
341257

Información Hospitalización

Unidad de Ingreso : Upc - Uci Adulto
Unidad de Egreso : Upc - Uci Adulto

Fecha Ingreso : 10/02/2023 10:41
Fecha Egreso : 13/02/2023 23:02

Días Estadía: 3

Motivo o Diagnóstico de Ingreso

GRAN QUEMADO

Comorbilidades

Procedimientos

Intervenciones Quirúrgicas

Epidemiología

Resumen Clínico

EPICRISIS UCI
13/02/2023

Antecedentes mórbidos: Desconocidos
Medicamentos: Desconocidos
Antecedentes quirúrgicos: Apendicectomía.

Anamnesis

Paciente es traído al servicio de urgencias de esta institución por personal del SAMU aproximadamente a las 07:38 AM posterior a sufrir incidente de tránsito de alta energía, colisión frontal mientras conducía moto con casco, el vehículo sufrió incendio que le causa quemadura por fuego. Al examen físico en la urgencia destaca:

- A.Quemadura de vibrisas, boca, cara, inmovilización cervical.
- B.Ventila espontáneamente.
- C.FAST negativo
- D.GSC 15/15, sin fococalización.
- E.Quemaduras en cara, cuello, torso, abdomen anterior y posterior, brazo, antebrazo izquierdo, manos, región genital, ambos muslos y piernas. Acortamiento y rotación externa de miembro inferior izquierdo.

Requiere intubación orotraqueal, inicia reposición de fluidos, se realiza TC de cerebro, cuello, tórax, abdomen y pelvis que revela

- Fractura inestable de pelvis observando pérdida de congruencia articular de articulaciones sacroilíacas de predominio izquierda y de la sínfisis del pubis. Fractura desplazada de procesos transversos sacros izquierdos, y fracturas no desplazadas de ramas ilíeo e isquiopubiana derechas.
- Hematoma en espacio prevesical con extensión a región escrotal y a región extraperitoneal posterior izquierda con pequeño foco de sangrado activo a este nivel.
- Opacidades parenquimatosas peri bronquiales pulmonares bilaterales, que puede estar determinadas por focos inflamatorios infecciosos versus focos pulmonares contusionales. Se sugiere controlar.
- Mínimo neumotórax apical izquierdo.
- Fractura no desplazada del 1ª arco costal posterior derecho

Fecha Epicrisis : 13/02/2023 23:16

- Colelitiasis.
- Nefrolitiasis derecha.

Según consta en parte operatorio:

Hallazgos.

Gran quemado + quemadura vía a: Quemadura por explosión 60% : Cara 4% AB-B, Cuello 2% AB-B, Tórax anterior 9% B, Abdomen 9% B anterior, ESI 9% Tipo B, EII 18% Tipo B, EID 9% Tipo B.

Procedimientos

· Aseo inicial con clorhexidina jabonosa por anterior y posterior, escarectomía superficial con compresas. Revisión de quemaduras y cálculo de SCQ.

· Asepsia de piel con clorhexidina líquida, instalación de campos estériles.

· Escarotomía de ESI, pared torácica izquierda, EII y muslo de EID.

· Incisión dorsal de pene + escarotomía escrotal.

· Cistostomía abierta.

· Identificación de fractura pélvica en libro abierto con salida de contenido hemático, se amplía a incisión mediana infraumbilical.

· Packing pre peritoneal con 3 compresas.

· Identificación de vejiga urinaria, sutura de jareta, incisión vesical saliendo orina oscura.

· Instalación de S. Foley 20Fr

· Cobertura de quemaduras con curación: telfa + apósito + venda gasa.

Durante procedimiento paciente grave, NAD 0,15. Caída de Hto 44 a 22. Temperatura 35°C.

Segundo tiempo por traumatología.

PELVIS

· Identificación bajo fluoroscopia punto de entrada supra acetabular

· Instalación de 2 schanz.

· Reducción con 2 barras. Adecuada reducción de diástasis de sínfisis. Disyunción posterior sin cambios.

RODILLA DERECHA

· Sin lesión ósea bajo fluoroscopia; rodilla inestable

· Instalación de fijador trans articular con 4 schanz y 3 barras

· Todos los componentes MOTAC

MUÑECA DERECHA

· Fractura de radio distal.

· Instalación de yeso ABP

Según parte anestésico

· Sangrado aproximado 2500 ml

· Glóbulos rojos 500 ml (2 U)

· PFC 1200ml (6 U)

· Diuresis 1220 ml

· Balance hídrico +4480 ml

· Noradrenalina hasta 0.14 ug Kg min

· Tiempo quirúrgico 07:30 H

· Se instaló CVC yugular izquierdo, LA braquial derecha.

Ingresa a UCI en el postoperatorio inmediato.

Al examen físico, se presenta Sedoanalgesiado hasta RASS -4, edema palpebral a predominio derecho, pupilas difícil de evaluar, impresionan isocóricas, mióticas, hiporreactivas; intubado, TET fijo a arcada dentaria con alambre, regular entrada de aire bilateral, se auscult a a través de ventajes, hipoventilación bilateral, ventilación mecánica protectora 6.5 ml Kg de peso, mejor PEEP 5, onda cuadrada, Ti 0.7 seg, FiO2 100%, SaTO2 90%, FR 23, P meseta 21, PEEP total 9 (auto PEEP que disminuye a 7 optimizando VMI), DP 11, abdomen y extremidades cubiertas por apósitos limpios y secos, se mantiene sobre sabanas estériles, T° 34.5 °C, se coloca manta calefactora, noradrenalina a 0.16 ug Kg min, llenado capilar 4 segundos.

Por formula Parkland debería recibir 19.2 L de lactato de Ringer. Ingresa con un balance positivo de 4.000 ml en las primeras 12 H.

Evoluciona rápidamente con hipotensión, requiere aumento de noradrenalina hasta 0.6 ug Kg min, taquicardia, requiere reanimación por volumen, LR 650 ml H EV por BIC, además un total de 2000 cc de LR y 200 ml de albumina al 20%, con esto

Fecha Última Actualización: 13-02-2023 23:16:03

Página 3 de 4

se logra estabilizar hemodinamia con TAM alrededor de 65 $\pm$ 70 con noradrenalina hasta 0.25 ug Kg min.

Diagnósticos de ingreso:

1) Politraumatismo grave:

A) Gran quemado, 60% de superficie corporal (quemadura por explosión)

-Cara 4% AB $\pm$ B

-Cuello 2% AB -B

-Tórax anterior 9% B

-Abdomen anterior 9% B

-ESI 9% B

-EII 18% B

-EID 9% B

-Índice Garcés 203 (Sobrevida excepcional).

B) Trauma pélvico cerrado

A) Fractura de pelvis en libro abierto

B) Luxación de rodilla derecha

C) Fractura antebrazo derecho

3) Antecedentes

Evolución en UCI:

-Hemodinamia: Paciente ingresa con altos requerimientos de NAD hasta 0.6 mcg/kg/min que posterior a reanimación con cristaloides y coloides logra disminuir a 0.25 mcg/kg/min, hoy se recibe con BIC de NAD a 0.28 mcg/kg/min se va reanimando por metas disminuyendo NAD hasta 0.2 mcg/kg/min; desde la microhemodinamia lactato inicial 17.6 DCO2 7.3 SVC 69% que luego de volemiar con lactato 11.7 DCO2 5.9 SVC 81.7%. Continuar volemización por metas.

-Ventilatorio: Con quemadura de vía aérea con falla ventilatoria severa al ingreso (Pa/Fi 79) por lo que se deja en SAS 1 en modalidad ACxVC con Fentanilo + Midazolam + BNM con Vecuronio con Pa/Fi hoy am en 228 que se recontrola en 217 sin posibilidad de decúbito prono por lo que agrego Ketamina por efecto broncodilatador con mejoría importante de mecánica toracopulmonar a PPI 21, DP 13, Cest 26 y autoPEEP 2. Pendiente fibrobroncoscopía; no disponible humidificación activa, luego de FBC iniciar nebulizaciones con HNF, N-Acetilcisteína y adrenalina racémica.

-Infeccioso: Con TAC de tórax con imagen compatible con neumonía aspirativa por lo que se solicita CAET y se inicia Ampicilina/Sulbactam; rescato CAET 10/02 con SAMS por lo que cambio a Cloxacilina. Seguimiento parámetros inflamatorios. Si fiebre pancultivar. Cursando coagulopatía por consumo por el momento sin requerimiento de transfusión de hemoderivados.

-Quirúrgico: Se realizó aseo quirúrgico el 10/02 por Cirugía plástica y el 12/02 por Cirugía Residente; plan si se mantiene en UCI HSR sería nuevo aseo por Cirugía Plástica el 15/02.

-Social: Se entrega información a familiares de forma presencial; se explica gravedad, refieren comprender.

A las 23:00 del 13/02/2023 es trasladado en ambulancia de alta complejidad medicalizada con destino a unidad de quemados.

Egresado vivo, sedoanalgesiado hasta RASS -5, con relajación neuromuscular, intubado, conectado a ventilador mecánico, con noradrenalina hasta 0.10 ug Kg min, con los siguientes signos vitales:

TA: 147/82

SatO2 98% (FiO2 50%)

FC 97 latidos por minuto

Glucemia capilar: 89

Diagnóstico de Egreso

QUEMADURA DE SEGUNDO GRADO, REGION DEL CUERPO NO ESPECIFICADA - Diagnósticos de ingreso:

1) Politraumatismo grave:

A) Gran quemado, 60% de superficie corporal (quemadura por explosión)

-Cara 4% AB $\pm$ B

-Cuello 2% AB -B

-Tórax anterior 9% B

-Abdomen anterior 9% B

-ESI 9% B

-EII 18% B

-EID 9% B

-Índice Garcés 203 (Sobrevida excepcional).

Fecha Epicrisis : 13/02/2023 23:16

Página 3 de 4

Fecha Última Actualización: 13-02-2023 23:16:03

Página 4 de 4

B)Trauma pélvico cerrado
A)Fractura de pelvis en libro abierto
B)Luxación de rodilla derecha
C)Fractura antebrazo derecho

Condición de Egreso Otro

Egreso con Catéter Doble J:NO

A las 23:00 del 13/02/2023 es trasladado en ambulancia de alta complejidad medicalizada con destino a unidad de quemados. Egresado vivo, sedoanalgesiado hasta RASS -5, con relajación neuromuscular, intubado, conectado a ventilador mecánico, con noradrenalina hasta 0.10 ug Kg min, con los siguientes signos vitales:

TA: 147/82

SatO2 98% (FiO2 50%)

FC 97 latidos por minuto

Glucemia capilar: 89

Plan Post Alta

traslado a centro de quemados

Indicaciones

Tipo de Reposo : Absoluto

Régimen Alimentario : Enteral

Medicamentos :

Controles

INTERNO

Becado/Residente



Guillermo Molina Mancero

Médico Tratante (Staff)